

Çocuklarda Splenomegali — Değerlendirme Algoritması

Palpabl/büyük dalağa yapılandırılmış yaklaşım: eşlik eden bulgu ve tam kan sayımı ile mekanizmayı ayır (enfeksiyöz, hematolojik, konjestif/portal, infiltratif, immün), hedefe yönelik tetkik et.

Splenomegali

Mekanizmaya göre ayırım

0–18 yaş

Portal hipertansiyon vurgusu

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Sağlıklı yenidoğan/süt çocuğunda dalak **1–2 cm** palpabl olabilir; bunun ötesi araştırılır.

Masif splenomegali = dalak umbilikus hattını geçer / pelvise uzanır. Palpasyon şüpheliyse **USG ile uzunluk** (yaşa göre normale karşılaştır).

Öykü

- Ateş, gece terlemesi, **kilo kaybı**, halsizlik (enfeksiyon/malignite).
- Solukluk, sarılık, koyu idrar (**hemoliz**); kanama/morarma.
- Karaciğer hastalığı / **yenidoğan umbilikal kateter** öyküsü (portal ven trombozu), bilinen kolestaz.
- Seyahat/endemik bölge (sıtma, visseral leishmaniazis), temas, aile öyküsü (hemoglobinopati, depo hastalığı).

Muayene

- Hepatomegali**, lenfadenopati, peteşi/purpura, sarılık, solukluk.
- Portal hipertansiyon: **karın duvarı venleri**, **asit**, hemoroid.
- Dismorfizm / nörogelişimsel gerileme (**depo hastalığı**).
- Büyüme eğrisi, kalp üfürümü (endokardit), döküntü/artrit.

Enfeksiyöz

- Viral: **EBV**, CMV, viral hepatit, HIV
- Bakteriyel: sepsis, **endokardit**, tifo, bruselloz, TB
- Paraziter: **sıtma**, visseral leishmaniazis (kala-azar)

Hematolojik

- Hemolitik anemi: **talasemi**, hereditör sferositoz, orak hücre
- Malignite: **lösemi**, **lenfoma**
- Ekstramedüller hematopoez

Konjestif (portal HT)

- **Siroz** (biliyer atrezi sekeli, otoimmün, metabolik)
- **Portal/splenik ven trombozu**, kavernom
- Budd-Chiari, konjestif kalp yetmezliği

İnfiltratif / depo

- **Gaucher**, Niemann-Pick
- Mukopolisakkaridozlar
- **HLH**, histiyositoz

İmmün / enflamatuar

- **SLE**, JİA / makrofaj aktivasyon sendromu
- Sarkoidoz
- Otoimmün lenfoproliferatif sendrom (ALPS)

Diğer / yapısal

- Dalak kisti, hemanjiyom
- Travma sonrası, apse
- Aksesuar dalak (yalancı kitle)

03 Karar akışı

Öykü/muayene → **TKS + periferik yayma + retikülosit** ile yönü belirle → baskın bulguya göre dallan → USG/Doppler ile yapı ve portal sistemi değerlendir → gerekiyorsa kemik iliği/genetik/metabolik.

BAŞLANGIÇ

Palpabl / büyük dalak doğrulandı

USG ile boyutu teyit et. Öykü + muayene ile eşlik eden bulguları topla.

ADIM 1 · TEMEL

TKS + periferik yayma + retikülosit

Sitopeni, blast, atipik lenfosit, hemoliz bulgusu (sferosit, orak, parçalanma) yönü belirler. + CRP, LDH, KCFT.

KARAR 1

Sitopeni / blast / lenfadenopati + sistemik bulgu?

Pansitopeni, çevresel blast, kilo kaybı/gece terlemesi, yaygın LAP.

EVET → malignite/HLH yolu

HAYIR → mekanizmaya göre

İVEDİ

Hematoloji-onkoloji ile birlikte

Kemik iliği aspirasyon/biyopsi; HLH için ferritin, trigliserid, fibrinojen, sIL-2R. Lenfoma için görüntüleme/biyopsi.

DALLAN

Baskın ipucuna yönel

Hemoliz / portal HT / enfeksiyon paternine göre ilerle.

KARAR 2

Hemoliz bulgusu var mı?

Anemi + retikülositoz + indirekt bilirubin/LDH ↑, haptogloblin ↓.

EVET → hemoliz paneli

HAYIR → devam

HEMATOLOJİK

Hemolitik anemi tetkiki

SONRAKİ

Portal / enfeksiyon değerlendirmesi

Karaciğer ve portal sistemi, ardından enfeksiyonu ele al.

Coombs, hemoglobin elektroforezi (talasemi/orak), eritrosit morfolojisi/EMA (sferositoz), G6PD.

ADIM 2 · GÖRÜNTÜLEME

Karın USG + Doppler

Dalak yapısı (kist/kitle/infarkt), karaciğer parankimi, **portal ven açıklığı/akımı**, kavernom, kollateral, asit. Portal HT bulgusu varsa hepatoloji yoluna gir.

KARAR 3

Portal hipertansiyon bulgusu var mı?

EVET → hepatoloji yolu

HAYIR → enfeksiyon/depo

KONJESTİF

Karaciğer/portal etiyoloji

KCFT + sentetik fonksiyon, viral/otoimmün/metabolik karaciğer tetkiki; portal ven trombozu ise trombofili; **varis için üst endoskopi**.

ADIM 3

Enfeksiyon serolojisi ± depo taraması

EBV/CMV, HIV, endemikse sıtma yayması/leishmania. Açıklanamayan + dismorfizm/nöroregresyon → **enzim/genetik (Gaucher vb.)**.

Hedefe yönelik tetkikler		
BASAMAK	HEDEF	TESTLER
Temel	Yön belirleme	TKS, periferik yayma , retikülosit, CRP/ESR, LDH, KCFT, ürik asit
Hemoliz	Hemolitik anemi	Coombs, haptoglobin, indirekt bilirubin, Hb elektroforezi, EMA testi, G6PD
Enfeksiyon	Viral/paraziter	EBV/CMV serolojisi, HIV, kan kültürü, sıtma yayması, leishmania (endemik)
Görüntüleme	Yapı + portal sistem	Karın USG + Doppler (portal ven, kavernom, karaciğer, asit)
Konjestif	Portal HT / karaciğer	Sentetik fonksiyon (INR/albumin), viral/otoimmün/metabolik panel, üst endoskopi (varis)
İnfiltratif	HLH / malignite	Ferritin, trigliserid, fibrinojen, sIL-2R; kemik iliği ; görüntüleme/biyopsi
Depo	Lizozomal/metabolik	Enzim düzeyi (β -glukoserebrosidaz vb.), genetik panel
İmmün	Otoimmün/enflamatuar	ANA/dsDNA, kompleman; ALPS için ilgili tetkik

● **Pansitopeni** veya çevresel **blast** → lösemi

● **Gece terlemesi, kilo kaybı**, yaygın LAP → lenfoma

● **Masif splenomegali** (pelvise uzanan)

● Portal HT: **varis kanaması**, asit, karın venleri

● **HLH**: sürekli ateş + sitopeni + **ferritin çok yüksek**

● Hızlı büyüyen dalak, şiddetli karın ağrısı → infarkt/rüptür

● Nöroregresyon + dismorfizm → depo hastalığı

● Sepsis / endokardit bulguları

İlke

- **Altta yatan nedene yönelik tedavi** esastır; splenomegali başlı başına tedavi hedefi değildir.
- **Hipersplenizm** (sitopeni) ve semptomatik/masif dalakta **splenektomi** multidisipliner değerlendirilir; mümkünse ertelenir/kısmi splenektomi.
- Portal HT'de **varis izlemi** ve gerektiğinde endoskopik tedavi/şant.

Aspleni/hipospleni önlemleri

- Splenektomi öncesi/sonrası **aşı**: pnömokok, **Hib**, meningokok (ACWY + B); influenza.
- **Antibiyotik profilaksisi** (penisilin) ve ateşte acil değerlendirme — **OPSI** riski.
- Aile eğitimi, tıbbi uyarı kartı.

Travma/rüptür riski: Belirgin splenomegalide (özellikle akut **EBV**) temas ve çarpışmalı sporlardan kaçınılmalı; genellikle dalak normale dönene / güvenli kabul edilene dek (çoğu vakada ~3–4 hafta ve semptomlar geriledikten sonra) kısıtlama önerilir.

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. Tetkik derinliği çocuğun yaşı, eşlik eden bulgular ve klinik gidişe göre bireyselleştirilmelidir.

Kaynaklar

1. McCormick MC, ve ark. Splenomegaly. *Pediatr Rev.* (pediatrik splenomegali derlemesi) — tanısal yaklaşım.
2. Kliegman RM, ve ark. Nelson Textbook of Pediatrics — Splenomegali ve dalak hastalıkları bölümü.
3. Rubin LG, Schaffner W. Care of the Asplenic Patient. *N Engl J Med.* 2014;371(4):349–356 (aşı ve profilaksi ilkeleri).
4. Henter JI, ve ark. HLH-2004: Diagnostic and Therapeutic Guidelines for Hemophagocytic Lymphohistiocytosis. *Pediatr Blood Cancer.* 2007;48(2):124–131.